Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 3ª Vara Cível da Capital

, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810387

Processo nº 0141716-75.2023.8.17.2001

AUTOR(A): JOAO HENRIQUE BARBOSA

RÉU: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA

Vistos, etc ..

JOÃO HENRIQUE BARBOSA, devidamente qualificado nos autos, ajuizou **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS** em face da **UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,** igualmente qualificado.

Alega a parte autora que possui quadro depressivo recorrente (F33 – CID-10), sendo acompanhado pelo psiquiatra Dr. Leonardo Machado (CRM/PE – 18409). E, em paralelo, também faz psicoterapia com profissional da psicologia. Contudo, há cerca de 4 meses, teve recaída grave com ideação de suicídio e refratário às mudanças medicamentosas feitas. Assim, o médico assistente prescreveu o uso do fármaco Spravato, na dosagem recomendada de 84mg por aplicação, sendo 2 (duas) aplicações semanais no primeiro mês e, ultrapassado esse tempo, aplicação única semanal nos 5 (cinco) meses seguintes, na mesma miligramagem. Entretanto, para surpresa do autor, o tratamento foi negado pela operadora ré, sob o fundamento de verificada ausência de cobertura para a medicação solicitada.

Diante do acima exposto, a parte autora propôs a presente demanda, requerendo, em sede de tutela de urgência, a determinação para que a parte Ré forneça/custei o tratamento com SPRAVATO 84mg, administrado em ambiente ambulatorial/hospitalar, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. Requereu ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito pugna pela confirmação da tutela e indenização por danos morais.

Juntou documentos.

Decisão do juízo deferindo a gratuidade de justiça e determinando a intimação da parte autora, por seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias emendasse a inicial, sob pena de seu indeferimento, nos termos dos arts. 320, 321 e 330 do CPC/15, Id 151358513.

Petições da parte autora emendando à exordial, Id's 152935553 e 152935567, acompanhada do laudo médico (Id's 152935556 e 152935570).

Decisão, ID153251216, concedendo a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada para determinar que a ré, **no prazo de 5 (cinco) dias**, **forneça o medicamento Spravato, na dose de 84mg por aplicação, sendo duas (02) aplicações semanais no primeiro mês; depois, nos 5 (cinco) meses seguintes, fazer 84mg por aplicação, sendo uma (01) aplicação semanal, em regime de hospital-dia (ambiente hospitalar), em rede credenciada do plano Réu, sob pena de multa diária, tudo em conformidade com o que foi prescrito pelo médico assistente** (Id's 151031780, 152935556 e 152935570) até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de arcar com multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a incidir na hipótese de descumprimento desta ordem judicial, por cada dia de atraso, na forma contida no artigo 537 do CPC, limitado ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de execução das *astreintes*.

Ré devidamente intimada em 28/04/2023, id 153554212.

Petição da ré informando o cumprimento da liminar, id 153554212.

Contestação, id 155714818 alegando: inexistência de comprovação científica da medicação na prevenção do suicídio, em que pese ser indicado para diagnostico de depressão; hipótese contida no Enunciado 97 da JORNADA DE Direito da Saúde CNJ; que os procedimentos fora da previsão legal e contratual aumentam o risco precificado pela Operadora quando da oferta do produto contratado, geram um custo não previsto e, por fim, desequilibram a relação contratual e a gestão financeira; que o laudo médico não é absoluto , sendo necessária a realização de perícia judicial para confirmar a necessidade de uso pelo Autor; inexiste dano moral indenizável. Ao final, pugnou pela improcedência do pedido.

Réplica, id 165281350.

Petição da autora entendo não ter mais provas a ´produzir e requerendo o julgamento antecipado da lide.

É o que importa relatar. DECIDO.

Anuncio o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art.355, I do NCPC, tendo em vista que a prova documental já acostada é suficiente ao julgamento da lide não sendo necessária qualquer outra prova a ser produzida, a teor da prova pericial requerida pelo réu e neste ato indeferida, haja vista que o laudo do médico assistente é suficiente `a formação do convencimento do julgador.

Dito de outra forma. Tenho que o pedido de produção de prova pericial em questão não contribuirá com o deslinde da questão posta em juízo, bem como considero que o plano de saúde com a referida prova busca modificar o tratamento prescrito ao autor por seu médico assistente, o que não é admitido pela jurisprudência pátria, que entende que a opção do melhor tratamento do paciente deve ser feita pelo profissional de saúde que lhe assiste.

Enfrento o mérito

A necessidade premente do tratamento, para preservação da vida e saúde do Autor, encontra-se demonstrada através da documentação acostada sob os Id's 151031780, 152935556 e 152935570, onde consta laudo e solicitação de medicamento elaborado pelo médico assistente Dr. Leonardo Machado, CRM/PE nº. 18.409, indicando estar, o autor, com quadros depressivos recorrentes (F33 – CID-10), episódios depressivos graves e recorrentes com ideação de suicídio, necessitando do uso da medicação Spravato 84mg por aplicação, sendo duas (02) aplicações semanais no primeiro mês; depois, nos 5 (cinco) meses seguintes, fazer 84 mg por aplicação, sendo uma (01) aplicação semanal, que não restaram autorizados pela parte demandada.

Dito isso entendo que o tratamento perquirido tem urgência na sua realização, porquanto o transtorno psiquiátrico grave trata-se de doença que se não tratada em tempo hábil poderá trazer consequências severas ao paciente, ante a gravidade do quadro caso não medicado, conforme afirmação do médico assistente em seu laudo médico nos Id's 151031780 - Pág. 1, 152935556 - Pág. 1 e 152935570 - Pág. 1.

Ademais, sobre o direito material específico em questão, a lei 9.656/98 prevê expressamente a obrigatoriedade de cobertura das doenças listadas na "Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde". É o que se conclui da leitura de seu artigo 10, *caput* e §2º, que traz o chamado "plano-referência", de cobertura mínima devida a qualquer beneficiário do plano:

"Art. 10. É instituído o **plano-referência** de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, **compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil**, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, **das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei**, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

§ 2º ***As pessoas jurídicas*** que comercializam produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei ***oferecerão, obrigatoriamente***, a partir de 3 de dezembro de 1999, o plano-referência de que trata este artigo ***a todos os seus*** atuais e ***futuros consumidores.*** (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001 c/c ADI 1931, STF)"

O plano-referência, de oferta mínima obrigatória por parte das operadoras de planos de saúde, portanto, ressalvadas hipóteses dos incisos do artigo 10, abarca todos os tratamentos das doenças elencadas com CID (Cadastro Internacional de Doenças).

Sendo assim, basta que a parte autora, vinculada ao plano de saúde, junte atestado de profissional da saúde habilitado a tanto demonstrando necessidade de tratamento de doença sofrida pelo consumidor para que tenha direito à cobertura do tratamento, o que foi feito no caso em apreço (Id's 151031780, 152935556 e 152935570).

Portanto, a doença da qual padece o beneficiário do plano de saúde e o respectivo tratamento devem ser atestadas por profissional competente para tanto, de livre escolha da paciente, o que é assegurado pela própria lei 9.656/98 (art. 1º, I) e pela RN 428/ANS (art. 5º).

Assim, ao se considerar que a Lei nº 9.656/98, prevê em seu art. 10 a cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar de todas as doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, além de tratar-se de medicamento intranasal, não vejo razão para a recusa de cobertura na espécie, pois apesar de o fármaco se apresentar em forma de Spray nasal, a sua administração deve ser realizada sob supervisão de profissional de saúde e em estabelecimento de saúde, tal como estabelece a própria bula do remédio e como indicado pelo psiquiatra que assiste o demandante. Sendo assim, o paciente não se encontra internado em hospital, mas, para a administração do fármaco, necessita estar em ambiente comparável a um nosocômio e sob a supervisão de profissional de saúde. A bula do remédio estabelece, ainda que o "*Spravato® deve ser administrado em um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde e você será monitorado até ser considerado clinicamente estável e pronto para deixar o estabelecimento*[1] (file:///C:/Users/accsc/Desktop/Decis%C3%A3o%20Spray%20Depress%C3%A3o%20Concess%C3%A3o%20Gratuidc

Ressalte-se, ainda que, na relação de consumo, o contrato deve ser interpretado da maneira mais favorável à parte hipossuficiente, consubstanciado no art. 47 do CDC, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a doença restou comprovada, o fármaco é registrado na ANVISA e fora indicado pelo médico assistente como única solução para tratar o Autor.

Ora, o Autor tem quadro depressivo recorrente grave e com ideias de suicídio. Diversamente do que entende o réu o medicamento tem evidência científica parta o quadro depressivo após tentativas inexitosas com outros fármacos o que é o caso do autor , consoante laudo de id 152935556.

Não bastasse isso verificam-se a existência de Notas Técnicas nº 93152 e nº 103074, extraídas do sistema e-NatJus que demonstram a eficácia à luz das evidências científicas do fármaco para tratamento da patologia que acomete o demandante, como se vê:

Nota Técnica 93152

Data de conclusão: 06/09/2022 14:46:09

(...)

CID: F33.3 - Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave com sintomas psicóticos

Diagnóstico: Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave com sintomas psicóticos (CID10 F33.3) e Lesão autoprovocada intencionalmente por meios não especificados (CID10 X 84.0)

Meio(s) confirmatório(s) do diagnóstico já realizado(s): Documentação médica acostada aos autos.

(...)

Tecnologia: CLORIDRATO DE ESCETAMINA

Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia: A Escetamina é um novo antidepressivo que atua como um modulador do receptor de glutamato. Pela Anvisa, o SPRAVATO® é indicado para:

- Transtorno Depressivo Maior em adultos que não tenham respondido adequadamente a pelo menos dois antidepressivos diferentes com dose e duração adequadas para tratar o atual episódio depressivo moderado a grave (depressão resistente ao tratamento) em combinação com antidepressivos orais (tais como ISRS – Inibidores seletivos da recaptação de serotonina e ISRSN – Inibidores da recaptação de serotonina e norepinefrina).

- Em conjunto com terapia antidepressiva oral, para a rápida redução dos sintomas depressivos em pacientes adultos com Transtorno Depressivo Maior com comportamento ou ideação suicida aguda.

Não foi demonstrada efetividade de SPRAVATO® na prevenção do suicídio ou na redução da ideação ou comportamento suicida.

O medicamento, deve ser administrado exclusivamente em um hospital ou uma clínica especializada e na presença de um profissional da saúde. Isso se deve ao risco de sérios efeitos adversos resultantes da sedação e dissociação, além do potencial de abuso e uso indevido da droga. O spray deve ser administrado em conjunto com outro antidepressivo oral. As reações adversas mais comumente observadas nos pacientes tratados com Cloridrato de Escetamina foram dissociação, tontura, náusea, sedação, dor de cabeça, vertigem, disgeusia, hipoestesia, aumento da pressão arterial, ansiedade e vômito. Em cerca de 20% dos pacientes, mas sintomas com melhora rápida.

Há diversas metanálises, revisões sistemáticas e ensaios clínicos randomizados que sustentam seu uso para o quadro de depressão refratária os termos descritos acima.

Ainda será preciso mais evidência para o uso da medicação tornar-se padronizado. Entretanto, com os trabalhos disponíveis, é razoável tentar seu uso em pacientes que tenham doença muito grave e resistente a outras modalidades de tratamento.

(...)

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: CONSIDERANDO os diagnósticos de Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave com sintomas psicóticos e Lesão autoprovocada intencionalmente por meios não especificados - constantes no relatório médico acostado ao processo;

CONSIDERANDO a presença de depressão grave resistente ao tratamento e risco eminente de suicídio;

CONSIDERANDO que é uma droga com evidência de eficácia, justamente para pacientes com depressão grave e resistente a outros esquemas terapêuticos;

CONSIDERANDO que restou comprovada depressão resistente ao tratamento visto que há descrição pormenorizada de vários medicamentos já utilizados pela parte autora, com doses e tempos adequados, com falha terapêutica ou efeitos colaterais intoleráveis (Fluoxetina, Sertralina, Clomipramina, Imipramina, Amitriptilina, Lítio, Venlafaxina, Paroxetina, Escitalopram, Quetiapina);

CONSIDERANDO que se trata de paciente com quadro depressivo refratário a múltiplos tratamentos por via oral disponíveis via SUS e mesmo fora dele;

CONCLUI-SE que como foi utilizada extensa lista de medicações por via oral sem controle de sintomas, deve-se considerar pertinente a solicitação de escetamina, sendo este parecer favorável ao pleito, se for confirmado que a paciente segue em uso de algum tratamento antidepressivo via oral associado.

Há evidências científicas? Sim

Nota Técnica 103074

Data de conclusão: 03/11/2022 16:29:33

(...)

CID: F33.2 - Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos

Diagnóstico: Transtorno Depressivo Recorrente, Episódio Atual Grave Sem Sintomas Psicóticos

Meio(s) confirmatório(s) do diagnóstico já realizado(s): Atestado Médico Apresentado.

(...)

Tecnologia: CLORIDRATO DE ESCETAMINA

Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia: A Escetamina é um novo antidepressivo que atua como um modulador do receptor de glutamato. Pela Anvisa, o SPRAVATO® é indicado para:

- Transtorno Depressivo Maior em adultos que não tenham respondido adequadamente a pelo menos dois antidepressivos diferentes com dose e duração adequadas para tratar o atual episódio depressivo moderado a grave (depressão resistente ao tratamento) em combinação com antidepressivos orais (tais como ISRS – Inibidores seletivos da recaptação de serotonina e ISRSN – Inibidores da recaptação de serotonina e norepinefrina).

- Em conjunto com terapia antidepressiva oral, para a rápida redução dos sintomas depressivos em pacientes adultos com Transtorno Depressivo Maior com comportamento ou ideação suicida aguda.

Não foi demonstrada efetividade de SPRAVATO® na prevenção do suicídio ou na redução da ideação ou comportamento suicida.

O medicamento, deve ser administrado exclusivamente em um hospital ou uma clínica especializada e na presença de um profissional da saúde. Isso se deve ao risco de sérios efeitos adversos resultantes da sedação e dissociação, além do potencial de abuso e uso indevido da droga. O spray deve ser administrado em conjunto com outro antidepressivo oral. As reações adversas mais comumente observadas nos pacientes tratados com Cloridrato de Escetamina foram dissociação, tontura, náusea, sedação, dor de cabeça, vertigem, disgeusia, hipoestesia, aumento da pressão arterial, ansiedade e vômito. Em cerca de 20% dos pacientes, mas sintomas com melhora rápida.

Há diversas metanálises, revisões sistemáticas e ensaios clínicos randomizados que sustentam seu uso para o quadro de depressão refratária os termos descritos acima.

Ainda será preciso mais evidência para o uso da medicação tornar-se padronizado. Entretanto, com os trabalhos disponíveis, é razoável tentar seu uso em pacientes que tenham doença muito grave e resistente a outras modalidades de tratamento.

(...)

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos;

CONSIDERANDO que é uma droga com evidência de eficácia, justamente para pacientes com depressão grave e resistente a outros esquemas terapêuticos;

CONSIDERANDO que restou comprovada depressão resistente ao tratamento visto que há descrição pormenorizada de vários medicamentos já utilizados pela parte autora, com doses e tempos adequados, com falha terapêutica ou efeitos colaterais intoleráveis;

CONSIDERANDO que se trata de paciente com quadro depressivo refratário a múltiplos tratamentos por via oral disponíveis via SUS e mesmo fora dele;

CONCLUI-SE que como foi utilizada extensa lista de medicações por via oral sem controle de sintomas, deve-se considerar pertinente a solicitação de escetamina, sendo este parecer favorável ao pleito, se for confirmado que a paciente segue em uso de algum tratamento antidepressivo via oral associado.

Há evidências científicas? Sim

Em face de tais considerações, tem-se como devida a cobertura postulada, sobretudo porquanto concernente a medicamento prescrito pelo médico assistente, conhecedor das peculiaridades do quadro clínico da parte autora e previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, assim como tendo em vista a comprovação da eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico, atraindo o disposto na exceção prevista no inciso II do § 13 do art. 10 da lei nº 9.656/98, reputando-se absolutamente indevida eventual interpretação restritiva das diretrizes de utilização.

Quanto ao uso da medicação, destacam-se recentes julgados:

Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer julgada procedente. Inconformismo da ré. Descabimento. Preliminares de cerceamento de defesa, impugnação à justiça gratuita e denunciação da lide rejeitadas. Autora diagnosticada com quadro depressivo grave associado à possibilidade de cometimento de suicídio. Tratamento com o medicamento "Escetamina intranasal (Spravato)" prescrito pelo médico em virtude dos resultados insatisfatórios apresentados pelos inúmeros tratamentos anteriores. Necessidade do medicamento devidamente justificada pelo médico que acompanha a paciente. Medicamento de aplicação em ambiente hospitalar ou em clínica médica. Alegação de cobertura de tratamento não constante do rol da ANS. Recusa indevida. Jurisprudência do E. TJSP. Sentença mantida. Recurso improvido.

*(TJSP; Apelação Cível 1009862-24.2023.8.26.0114; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2024; Data de Registro: 30/05/2024)***menta:** APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS.* PLANO DE SAÚDE. *APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE SEM SINTOMAS PSICÓTICOS - DEPRESSÃO RESISTENTE A TRATAMENTO. PLEITO DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO* SPRAVATO *(CLORIDRATO DE ESCETAMINA). MEDICAMENTO DE USO AMBULATORIAL. ART. 12, I, ALÍNEA "B", DA LEI 9.656/98. COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA À LUZ DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DEVER DE COBERTURA VERIFICADO. 1. INCIDE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS DE* PLANO DE SAÚDE, *SALVO OS ADMINISTRADOS POR ENTIDADES DE AUTOGESTÃO, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 3º, §2º, BEM COMO PELO QUE DISPÕE A SÚMULA Nº 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O ARTIGO 35 DA LEI Nº 9.656/1998. 2. AS COBERTURAS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS POR* PLANOS DE SAÚDE *SE SUJEITAM A UM ROL MÍNIMO EDITADO PELA ANS, O QUAL NÃO PODE PREVER AS HIPÓTESES DO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98 E NÃO PODE EXCLUIR OU MITIGAR AS HIPÓTESES DO ART. 12 DA MESMA LEI. NÃO OBSTANTE, EVIDENTEMENTE QUE OS CONTRATOS FIRMADOS PODEM ALARGAR O ESPECTRO MÍNIMO DE COBERTURA, INCLUSIVE COBRINDO AS HIPÓTESES DO CITADO ART. 10. 3. NO PONTO, CUMPRE DESTACAR QUE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA CÍVEL, O ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM* SAÚDE *PUBLICADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE* SAÚDE *SUPLEMENTAR É TÃO SOMENTE REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS NOS* PLANOS *PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À* SAÚDE, *NÃO POSSUINDO CARÁTER TAXATIVO, O QUE FOI RATIFICADO PELA INCLUSÃO DO § 12 NO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98 PELA LEI Nº 14.454/2022, A QUAL POSSUI APLICABILIDADE IMEDIATA, SOBRETUDO AOS TRATAMENTOS DE CARÁTER CONTINUADO. 4. RESSALTE-SE, OUTROSSIM, QUE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA CÍVEL, É FACULTADO AOS* PLANOS DE SAÚDE *ESTABELECEREM PARA QUAIS PATOLOGIAS IRÃO OFERECER COBERTURA; NO ENTANTO, NÃO PODEM LIMITAR O TRATAMENTO, POIS ESTE CABE SOMENTE AO MÉDICO ASSISTENTE DO PACIENTE SEGURADO, CONHECEDOR DAS PECULIARIDADES DE SEU QUADRO CLÍNICO. 5. OUTROSSIM, CONSISTINDO EM TRATAMENTO DE USO AMBULATORIAL, AFIGURA-SE OBRIGATÓRIA A COBERTURA, POR SE TRATAR DE EXIGÊNCIA MÍNIMA DE FORNECIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 12, I, ALÍNEA "B", DA LEI Nº 9.656/98. 6. ADEMAIS, DENOTA-SE A EXISTÊNCIA DE NOTAS TÉCNICAS Nº 93152 E Nº 103074, EXTRAÍDAS DO SISTEMA E-NATJUS QUE DEMONSTRAM A EFICÁCIA À LUZ DAS EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DO FÁRMACO PARA TRATAMENTO DA PATOLOGIA QUE ACOMETE O DEMANDANTE. 7. EM FACE DE TAIS CONSIDERAÇÕES, TEM-SE COMO DEVIDA A COBERTURA POSTULADA, SOBRETUDO PORQUANTO CONCERNENTE A MEDICAMENTO PRESCRITO PELA MÉDICA ASSISTENTE, CONHECEDORA DAS PECULIARIDADES DO QUADRO CLÍNICO DA PARTE AUTORA E PREVISTO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM* SAÚDE *DA ANS, ASSIM COMO TENDO EM VISTA A COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA BASEADA EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E* PLANO *TERAPÊUTICO, ATRAINDO O DISPOSTO NA EXCEÇÃO PREVISTA NO INCISO II DO § 13 DO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98, REPUTANDO-SE, AO REVERSO DO SUSTENTADO PELA OPERADORA RÉ, ABSOLUTAMENTE INDEVIDA EVENTUAL INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. 8. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS, EM ATENÇÃO AO PRECONIZADO PELO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 51449620320228210001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 30-01-2024)*

O pedido de obrigação de fazer deve ser pois acolhido, devendo a tutela ser confirmada por seus fundamentos.

Quanto ao pedido indenizatório (dano moral)

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, este merece guarida, haja vista tendo em vista que a frustração de expectativa afeta a dignidade da pessoa humana.

É cediço que o mero descumprimento contratual não dá ensejo a dano moral indenizável, porém a regra não é absoluta. Assim sendo, é possível ocorrer dano moral diante de eventuais ilícitos de considerável gravidade ou injustificadamente protraídos.

Conquanto o mero descumprimento contratual não gera, em regra, danos morais, entretanto, no caso dos autos demonstra merecer tratamento diferenciado. A parte autora estava em situação de fragilidade emocional e física, ante o que demonstraram os documentos acostados, necessitando submeter-se ao uso de procedimento indispensável, suficientes para abalar a estrutura psíquica da postulante.

Suportando a autora não só o sofrimento físico, mas, também, a angústia de moléstia grave, cujo tratamento dependia do medicamento que deveria usar, a recusa do plano de saúde réu evidencia o abalo emocional, que não pode ser entendido como mero aborrecimento. Insofismável, no caso sob apreço, o dano moral que sofreu a demandante.

Dessa forma, não se pode negar que em determinados contratos, como os que envolvem planos/seguros de saúde, o inadimplemento pode gerar danos morais aos usuários, considerando que o objeto contratado abrange a vida e a saúde, bens supremos do ser humano.

De se observar que o Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, tem considerado que a negativa de cobertura de plano de saúde pode ensejar danos morais, senão vejamos:

*Civil. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais. Negativa ilegal de cobertura, pelo plano de saúde, a atendimento médico de emergência. Configuração de danos morais. - N**a esteira de diversos precedentes do STJ, verifica-se que a recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito daquele. Recurso especial provido** (Resp907718/ES, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, Superior Tribunal de Justiça, DJ 07/10/2008)*

A recusa da assistência, se deu no momento em que a parte Autora mais necessitava, representando afronta aos seus direitos de personalidade, pois, embora tenha contratado um plano de saúde justamente para evitar quaisquer complicações no momento em que eventualmente se deparasse com uma situação delicada, viu-se impedida de usufruir de direitos previstos no próprio contrato, para o qual contribuiu. Em casos semelhantes:

PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. FILHOS. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RECUSA INJUSTIFICADA EMCOBRIR OS GASTOS DO SEGURADO. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. I - Não se encontra caracterizada a divergência jurisprudencial em razão da dessemelhança fática entre o acórdão recorrido e o aresto paradigma colacionado. II - A recusa injustificada do plano de saúde em cobrir gastos cirúrgicos pode ensejar danos morais. Precedentes da Corte. Recurso especial não conhecido (955716/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, Superior Tribunal de Justiça, DJ 11/03/2008)Civil.

Ante as circunstâncias do fato ocorrido, e ainda considerando a extensão do dano, a título de indenização por danos morais, fixo o valor indenizatório na quantia certa **de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).**

Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, **JULGO PROCEDENTE** os pedidos para: **a)** confirmar a tutela de id nº ID 153251216 ; **b)** pagar a parte autora indenização a título de danos morais no valor de **R$ 5.000,00 (cinco mil reais),** atualizados pela tabela ENCOGE, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do arbitramento, eis que apenas aqui fixado o *quantum* devido (Súmula 362, STJ e REsp nº 888.751 – BA (20060207513-3) – DJe – 27/10/2011[1] e TJPE[2]. [1]

Anota-se ainda que: "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca." (Súmula 326/STJ).

Por fim, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (proveito econômico da obrigação fazer + dano moral), nos moldes do art. 82, §2º, cumulado com o art. 85, *caput*, §§2º e 8º, todos do NCPC.

Se interposto recurso de apelação, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões e, após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça.

Ficam as partes advertidas que o manejo de aclaratórios reconhecidos manifestamente protelatórios, ensejará na aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§2º , do NCPC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se arquivem-se os autos, observadas as cautelas de estilo.

Recife, 13 de junho de 2024.

Valéria Maria Santos Máximo

Juíza de Direito

---

[1] (file:///G:/3%20vara%20c%C3%ADvel%20%20nov%202022/Senten%C3%A7as%20novo%20atualizada/0141716%2(

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS FIXADOS NO 1º GRAU. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 362/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.

- Assente na jurisprudência do Col. STJ que o *dies a quo* de incidência da correção monetária sobre o montante fixado a título de indenização por dano moral decorrente de ato ilícito é o da prolação da decisão judicial que a quantifica (Súmula 362/STJ*), in casu*, o acórdão embargado, pois este modificou o valor arbitrado no juízo de 1º Grau.

- Omissão reconhecida. Embargos de declaração acolhidos. (TJPE, 009. 0000756-10.2013.8.17.0000 Embargos de Declaração (0289163-6/01), 2ª Câmara Cível, Relator Des. Eurico de Barros Correia Filho, j. 20/02/2013, DJe nº 37/2013, 26/02/ 2013, p. 230) (Grifos para destacar)

Assinado eletronicamente por: VALERIA MARIA SANTOS MAXIMO
17/06/2024 08:30:20
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 173435343

24061708302002500000169300148

IMPRIMIR GERAR PDF